BONUS 2

50 pogrešaka u opisu koje Vaš mentor najčešće ispravlja

50 pogrešaka zbog kojih se opisi vraćaju; svaka u obliku «Napisano → Ispravno → Razlog». Ispravite vlastiti opis prije nego što naiđete na crvenu olovku Vašeg mentora.

Sadržaj

Kako koristiti ovaj popis

Tehnika i usporedba — 6 pogrešaka

Terminologija — 7 pogrešaka

Lokalizacija, strana i mjerenje — 8 pogrešaka

Nalazi — 9 pogrešaka

Zaključak — 8 pogrešaka

Preporuka — 4 pogreške

Hitni nalaz i obavijest — 4 pogreške

Oblik i prije potpisa — 4 pogreške

Sljedeći korak

NA POČETKU

Kako koristiti ovaj popis

Pogreške su grupirane prema metodi u 4 koraka: PRIPREMITE, PREGLEDAJTE, OPIŠITE, SAŽMITE.

> *Većina pogrešaka u opisu ne proizlazi iz nedostatka znanja, nego iz navike. A navika se ispravi čim se jednom uoči.*

KORAK U METODI	POVEZANE SKUPINE POGREŠAKA
PRIPREMITE	Tehnika i usporedba
PREGLEDAJTE	Nalazi (propusti i važni negativni nalazi)
OPIŠITE	Terminologija · Lokalizacija, strana i mjerenje · Nalazi
SAŽMITE	Zaključak · Preporuka · Hitni nalaz i obavijest · Oblik i prije potpisa

1. **Tijekom jednog tjedna svaki dan pročitajte jednu skupinu.** Osam skupina, osam dana.
2. **Svaki opis koji je Vaš mentor ispravio usporedite s ovim popisom.** Ako se ista pogreška ponovi dvaput, dodajte je na svoj kontrolni popis.
3. **Prije potpisa primijenite Kontrolni popis opisa na jednoj stranici.** Stavke na popisu sažetak su ovih 50 pogrešaka.

Praksa ustanove

Ako se format opisa ili terminološke preferencije Vašeg odjela razlikuju od ovdje navedenih primjera, vrijedi pravilo Vašeg odjela. Glavni je cilj usvojiti načelo: jasan, odmjeren, usporedni opis koji odgovara na pitanje.

SKUPINA 1

Tehnika i usporedba

6 pogrešaka · Napisano → Ispravno → Razlog

BR.	NAPISANO	ISPRAVNO	UZROK
01	Polje tehnike ostavljeno je prazno.	«Nativni CT mozga; aksijalni presjeci procijenjeni su u moždanom i koštanom prozoru.»	*Čitatelj ne može procijeniti snagu nalaza ako ne zna koja je pretraga procijenjena i u kojim uvjetima.*
02	«CT abdomena s IV kontrastom.»	«CT abdomena i zdjelice s IV kontrastom, portalna venska faza.»	*Faza određuje hoće li se nalaz vidjeti; bez podatka o arterijskoj fazi ne može se tumačiti aktivno krvarenje.*
03	Nije navedena tehnička nedostatnost (artefakt pomicanja, nedovoljan udah).	«Procjena stražnje lubanjske jame ograničena je zbog artefakta pomicanja.»	*Ako se ograničenje ne navede, rečenica «bez nalaza» čita se pouzdanijom nego što zapravo jest.*
04	«Uspoređeno s prethodnom pretragom.»	«**[Datum]**: uspoređeno s CT-om prsnog koša od navedenog datuma.»	*Bez datuma i modaliteta ne može se provjeriti s kojom je pretragom uspoređeno.*
05	Iako postoji prethodna pretraga, usporedba nije učinjena.	«U usporedbi s prethodnom pretragom veličina čvora **[.. mm]** → **[.. mm]**: porast.»	*Glavno pitanje kontrolne pretrage najčešće je promjena; bez usporedbe opis ne odgovara na pitanje.*
06	«Usporedba: nema.»	«Nema prethodne pretrage za usporedbu.»	*«Nema» je nejasno: nema ga u sustavu ili nije pregledano? Jasna rečenica uklanja to pitanje.*

SKUPINA 2

Terminologija

7 pogrešaka · Napisano → Ispravno → Razlog

BR.	NAPISANO	ISPRAVNO	UZROK
07	Na CT-u «hiperintenzivna lezija».	Na CT-u «hiperdenzna lezija».	*Na CT-u se koristi denzitet, na MR-u signal, a na UZV-u ehogenost; pogrešan pojam ostavlja dojam da ne poznajete modalitet.*
08	Na UZV-u «hipodenzna masa».	Na UZV-u «hipoehogena masa».	*Ehogenost je pojam svojstven UZV-u.*
09	Za cistu «hipoehogena».	Za jednostavnu cistu «anehogena».	*Anehogeno i hipoehogeno znače različit sadržaj; dijagnoza jednostavne ciste temelji se na toj razlici.*
10	«Prikazan je tumor.»	«**[.. mm]** prikazana je ekspanzivna lezija.»	*Tumor je histološka dijagnoza; slikovni nalaz opisuje se kao masa ili lezija.*
11	«Infiltracija» (za svako zasjenjenje na snimci).	Opisni pojam poput «konsolidacija», «mliječno staklo», «retikularno zasjenjenje».	*«Infiltracija» je nejasan pojam i različitim liječnicima znači različito.*
12	«Postoji učinak mase.»	«Izbrisanost brazda, kompresija ipsilateralnog ventrikula i **[.. mm]** pomak središnje linije.»	*Stupanj učinka mase treba navesti mjerom i nalazom; o tome ovisi kliničko odlučivanje.*
13	«U granicama normale» (za sve).	Kratko navedite relevantne organe jedan po jedan: «Jetra, slezena i bubrezi uredni.»	*Ostaje nejasno što je procijenjeno; čitatelj ne može uočiti izostavljeni organ.*

SKUPINA 3

Lokalizacija, strana i mjerenje

8 pogrešaka · Napisano → Ispravno → Razlog

BR.	NAPISANO	ISPRAVNO	UZROK
14	Strana nije navedena: «Pleuralni izljev.»	«Desnostrani pleuralni izljev.»	*Izostanak strane može dovesti do ozbiljne pogreške kod zahvata poput torakocenteze ili operacije.*
15	Pogrešna strana zaostala iz predloška.	Strana se još jednom provjerava prema oznaci na snimci i uputnici.	*To je najopasnija od pogrešaka kopiranja i lijepljenja; strana u Nalazima i Zaključku mora biti ista.*
16	«Lezija u lijevom plućnom krilu.»	«Lezija u gornjem segmentu lijevog donjeg režnja.»	*Podatak o režnju i segmentu potreban je i za praćenje i za planiranje bronhoskopije ili biopsije.*
17	«Velika masa», «mali čvor».	«**[.. x .. mm]** masa», «**[.. mm]** čvor».	*Pridjevi nisu mjera; promjena pri praćenju može se procijeniti samo brojem.*
18	Izmjerena je samo jedna dimenzija, ravnina nije navedena.	«U aksijalnoj ravnini **[.. x .. mm]**, kraniokaudalno **[.. mm]**.»	*Mjerenje u drugoj ravnini pri praćenju daje lažan dojam porasta ili smanjenja.*
19	Mjera bez jedinice: «Čvor 8.»	«Čvor **[.. mm]**.»	*Broj bez jedinice može se pogrešno očitati i medicinsko-pravno je neobranjiv.*
20	Kod lezije jetre «u desnom režnju».	«Segment **[..]**».	*Podatak o segmentu standard je za kirurško i intervencijsko planiranje.*
21	Kod prijeloma rebra nema broja.	«Desno **[..]**. rebro, prijelom lateralnog luka.»	*Koje je rebro slomljeno potrebno je za praćenje i usklađivanje s kliničkim pregledom.*

SKUPINA 4

Nalazi

9 pogrešaka · Napisano → Ispravno → Razlog

BR.	NAPISANO	ISPRAVNO	UZROK
22	Zaustavilo se na prvom nalazu; drugi je nalaz propušten.	Svaka se regija svaki put pregledava istim redoslijedom; zapisuje se i drugi nalaz.	*«Zaustavljanje nakon pronađenog nalaza» (satisfaction of search) najčešći je uzrok propusta.*
23	Nije naveden važan negativni nalaz (kod pitanja o apendicitisu apendiks se ne spominje).	«Apendiks normalnog izgleda; znakovi akutnog apendicitisa nisu utvrđeni.»	*Ako se ne navede organ na koji se odnosi kliničko pitanje, kliničar ne može znati je li procijenjen.*
24	Kod pitanja o krvarenju ne spominje se koštani prozor.	«U koštanom prozoru nije prikazan prijelom kalvarije.»	*Procjena prijeloma na CT-u kod traume zahtijeva koštani prozor; ako se to ne napiše, pretpostavlja se da nije pregledan.*
25	Nalazi pomiješani s tumačenjem: «Prikazana je pneumonija.»	U Nalazima: «Konsolidacija sa zračnim bronhogramom.» U Zaključku: «Može odgovarati pneumoniji.»	*Nalazi sadrže opažanje, a Zaključak tumačenje; kad se to dvoje pomiješa, opis je teško obraniti.*
26	Cijevi i kateteri nisu spomenuti.	«Vrh ETT-a nalazi se **[.. cm]** iznad karine; vrh CVK-a u projekciji gornje šuplje vene.»	*Najčešće kliničko pitanje kod snimki iz jedinice intenzivnog liječenja jest položaj uređaja.*
27	Izostavljene su ostale strukture u vidnom polju (gornji abdomen na CT-u prsnog koša).	«Na prikazanim presjecima gornjeg abdomena **[patologija nije prikazana/..]**.»	*Svaka struktura u vidnom polju odgovornost je onoga tko opisuje; lezije nadbubrežne žlijezde ili jetre često se previde.*
28	Isti nalaz ponovljen je tri puta u Nalazima.	Svaki se nalaz piše jednom, pod pripadajućim organom.	*Ponavljanje produljuje opis i otežava čitatelju da pronađe glavni nalaz.*
29	Koštana lezija bez opisa: «Lezija u kosti.»	«**[Kost]**: **[.. mm]**, **[litička/sklerotična]**, **[uska/široka]** lezija s prijelaznom zonom; periostalna reakcija **[nema/ima]**.»	*Karakter koštane lezije (prijelazna zona, matriks, periost) određuje diferencijalnu dijagnozu.*
30	Za kolekciju tekućine nisu navedeni sadržaj i mjera.	«**[.. x .. mm]**, s perifernom imbibicijom kontrastom, unutar nje zrak **[nema/ima]** kolekcija.»	*Odluka o drenaži donosi se prema veličini, sadržaju i obilježjima stijenke.*

SKUPINA 5

Zaključak

8 pogrešaka · Napisano → Ispravno → Razlog

BR.	NAPISANO	ISPRAVNO	UZROK
31	Zaključak je kopija Nalaza.	U Zaključku samo značajni nalazi i njihovo tumačenje, prema redoslijedu važnosti.	*Dio Zaključak sažetak je i tumačenje nalaza; kopija pokazuje da tumačenja nema.*
32	Zaključak ne odgovara na kliničko pitanje.	Prva rečenica odgovara na kliničko pitanje: «Znakovi akutnog apendicitisa nisu utvrđeni.»	*Liječnik koji je napisao uputnicu odgovor na svoje pitanje traži u prvoj rečenici.*
33	Incidentalni nalaz na prvom mjestu, hitni nalaz na kraju.	Hitni nalaz uvijek je na prvom mjestu; incidentalni nalazi na samom kraju.	*Čitatelj najčešće pročita samo prvi redak.*
34	«Preporučuje se korelacija s kliničkim nalazom» (u svakom opisu, bez obrazloženja).	Napišite s čime i zašto treba korelirati: «Preporučuje se korelacija s laboratorijskim pokazateljima infekcije.»	*Neobrazložena preporuka korelacije ne nosi informaciju i smanjuje vjerodostojnost opisa.*
35	Dug i izbjegavajući popis diferencijalnih dijagnoza.	Najprije najvjerojatnija dijagnoza, zatim najviše dvije do tri realne diferencijalne dijagnoze.	*Popis od deset stavki ne usmjerava kliničara; usmjerava ga redoslijed vjerojatnosti.*
36	«Malignost se ne može isključiti» (bez obrazloženja).	Navedite nalaze u prilog malignosti ili protiv nje te preporučeni sljedeći korak.	*Neobrazloženo «ne može se isključiti» stvara nepotrebnu zabrinutost i lanac pretraga.*
37	Stupanj sigurnosti nejasan: «Pneumonija?»	«Odgovara pneumoniji» / «u prilog pneumoniji» / «može biti pneumonija» — odaberite što od toga vrijedi.	*Upitnik nije jezik opisa; stupanj sigurnosti izražava se standardnim formulacijama.*
38	U Zaključku nema promjene u odnosu na prethodnu pretragu.	«U usporedbi s prethodnom pretragom [u .. leziji] regresija.»	*Pri kontrolnoj pretrazi kliničko se odlučivanje temelji na promjeni.*

SKUPINA 6

Preporuka

4 pogreške · Napisano → Ispravno → Razlog

BR.	NAPISANO	ISPRAVNO	UZROK
39	«Preporučuje se daljnja obrada.»	«Radi karakterizacije preporučuje se MR mozga s kontrastom.»	*Ako se ne napiše koja pretraga i zašto, preporuka se ne može provesti.*
40	Svakom je nalazu dodana preporuka za praćenje.	Specifična preporuka samo za nalaze koji mijenjaju kliničku odluku.	*Nepotrebna preporuka znači nepotrebnu pretragu, trošak i zabrinutost bolesnika.*
41	Upisan je interval praćenja u koji autor nije siguran.	«Potrebu za praćenjem treba odrediti zajedno s kliničkim timom prema važećim smjernicama.» — ili pitajte Vašeg mentora.	*Pogrešan interval može naštetiti bolesniku; ako niste sigurni u broj, ne pišite ga.*
42	Napisana je preporuka liječenja: «Treba započeti antibiotsku terapiju.»	«Može odgovarati pneumoniji.»	*Odluka o liječenju pripada kliničkom timu; radiološki opis pruža dijagnostičke informacije.*

SKUPINA 7

Hitni nalaz i obavještavanje

4 pogreške · Napisano → Ispravno → Razlog

BR.	NAPISANO	ISPRAVNO	UZROK
43	Hitni nalaz naveden je u opisu, ali nije prijavljen.	Obavijestite telefonom i zabilježite u opisu: «Kliničkom timu [vrijeme]: priopćeno.»	*Vrijeme do čitanja opisa može biti kritično za bolesnika.*
44	Obavijest je dana, ali je nema u opisu.	«[Vrijeme] u [jedinica] dežurnom liječniku priopćeno telefonom.»	*Obavijest koja nije zapisana medicinsko-pravno se može smatrati neobavljenom.*
45	Zapis o obavijesti: «rečeno liječniku».	Kome (titula i odjel), u koliko sati, kojim putem i je li obavljeno ponovno čitanje.	*Nejasan zapis onemogućuje provjeru obavijesti.*
46	Hitni nalaz nalazi se u sredini Zaključka.	Hitni nalaz prva je rečenica Zaključka.	*Kliničar koji brzo čita može stati već na prvom retku.*

SKUPINA 8

Oblik i prije potpisa

4 pogreške · Napisano → Ispravno → Razlog

BR.	NAPISANO	ISPRAVNO	UZROK
47	U opisu su ostale uglate zagrade ili tekst predloška.	Prije potpisa [ ] i oznake «...» traže se i brišu.	*Preostali tekst predloška pokazuje da je opis poslan bez čitanja.*
48	Ime bolesnika, datum pretrage ili uputnica ne podudaraju se.	Identitet bolesnika, datum i vrsta pretrage usklađuju se s opisom.	*Opis koji pripada pogrešnom bolesniku jedna je od najtežih pogrešaka u opisivanju.*
49	Kratice su korištene bez objašnjenja (one koje nisu uvriježene).	Kraticu koja nije uvriježena pri prvoj uporabi napišite u cijelosti.	*Opis se ne piše samo za radiologe, nego za sve kliničare.*
50	Pogreška u diktiranju ili tipfeler: «lijevo» umjesto «desno», «hipo» umjesto «hiper».	Prije potpisa jednom pročitajte opis od početka do kraja.	*Pogreška u jednom slovu može preokrenuti značenje nalaza.*

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Sada otvorite Bonus 3 · Opis prema kliničkom pitanju: 30 kliničkih pitanja. Velik dio pogrešaka nastaje zato što opis ne odgovara na kliničko pitanje; pogledajte na što opis obvezno mora odgovoriti kod 30 najčešćih pitanja.

Za ispravne obrasce rečenica **Bonus 1 · Banka od 200 zaključaka opisa** se možete vratiti.